

כוויות

מקרי כוויות אף הם קשים יותר בקרב קשישים ויש עלייה בתמותה מכוויות בשל כמה סיבות. ראשית, היות שבדרך כלל כמות השומן בגוף פחותה אצל קשישים יש פחות הגנה והדבר עלול לגרום לנזק נרחב לרקמות עמוקות. פרט לכך, הירידה בתפקוד מערכת החיסון גורמת לעלייה בסיכון להופעת זיהומים בגלל הפגיעה במנגנון ההגנה של העור. בעיה נוספת קיימת במאזן הנוזלים. דרך הרקמה הפגועה וסביבה אובדים נוזלים בכמויות משמעותיות. לא תמיד אפשר להחזיר נוזלים בעירוי תוך-ורידי - במקרה של איספיקת לב ובשל החשש לבצקת ריאות. כמו כן, ברקמת העור המזדקנת יש פחות בלוטות זיעה וחלב ורקמת היפודרמיס והדבר יכול לגרום לפגיעה בווטוסות חום הגוף ולהגברת הסיכון להיפותרמיה. גם ההחלמה מכוויות קשה יותר בקרב קשישים. כל נפגע כוויה זקוק לחלבון בכמויות מוגברות כדי להתמודד עם שיקום הרקמות. רמת החלבון והאלבומין בגוף הקשיש היא פעמים רבות נמוכה, לעיתים נוספת אליה תת-תזונה ואף הן מקשות על ההחלמה.

בכל מקרה של כוויות יש לתת דגש לסימנים המחשידים להזנחה ולהתעללות פיזית או מינית.

פינוי

כמו במקרי טראומה אחרים, חשוב ביותר להקפיד על פינוי מהיר למתקן רפואי מתאים. גם בהיבט זה, הקשיש הוא שמקבל את ההחלטה לגבי כל הצעדים הטיפוליים שבידינו להציע. אם הוא צלול, זכותו של הקשיש לסרב לטיפול או לפינוי, ולמשפחה אין מעמד חוקי בהקשר זה, אלא אם כן יש אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט או אם הקשיש דמנטי או שאינו מתקשר. לכן, כמו בכל טיפול רפואי, יש להסביר למטופל עצמו, לוודא שהוא מבין ולקבל את הסכמתו מדעת. וחשוב להיזהר שלא להיגרר למלא את בקשות בני המשפחה או המטפלים של הקשיש אם הן לא עולות בקנה אחד עם בקשת המטופל.

להזכירכם - החובש אינו עושה הבחנות כאלה. אדם מוגדר דמנטי על ידי הרופא המטפל, נירולוג או בית משפט.

נכים

בטיפול בנכים יש להביא בחשבון מגבלות פיזיות, שימוש במכשירי עזר כגון כיסאות גלגלים, מכשירי הנשמה ואחרים שיש להביא אותם בחשבון בטיפול ובפינוי. על המטפלים להיות ערים לדקויות ולצרכים המיוחדים כדי לתת את הטיפול ההולם ולהימנע מדעות קדומות. יש להדגיש שאין מדובר כאן בטיפול בנכות עצמה אלא בטיפול חירום בלבד.

עקרונות טיפולי החירום וטיפול השגרה זהים בין מטופלים עם נכות ובין מטופלים ללא נכות.

מן המטפל נדרשת מודעות להתאמות הנדרשות למטופל הנכה.

את הנכויות הפיזיות מחלקים לשלוש:

- (1) **נכות קלה** - שבה האדם במצב תפקודי סביר ולעיתים אף הולך בכוחות עצמו אך יש לו מגבלה קלה היכולה להתבטא לדוגמה בצליעה או בחולשת צד.
- (2) **נכות בינונית** - לדוגמה, אדם המרותק לכיסא גלגלים.
- (3) **נכות קשה** - למשל אדם עם שיתוק מלא.

דגשים בטיפול ובפינוי

על המטפל להביא בחשבון שני קשיים: טיפול חירום ופינוי.

(א) **אבחנת בעיית החירום והושטת הטיפול המתאים** - האבחנה יכולה להיטשטש משנית לבעיית הבסיס. הקושי באבחון יכול לנבוע מהשפעה תרופתית או משיתוק מוטורי שלא מאפשר הערכה נירולוגית. ייתכן גם קושי בהגשת פעולות החירום - ABCD.

(ב) **שאלה לוגיסטית הקשורה בניוד ובפינוי** - יש סוגי נכויות שאמצעי ההעברה העומדים לרשות הצוות הרפואי אינם מתאימים להם.

בבסיס הגישה למטופל עם נכות פיזית צריכה לעמוד ההבנה שהמטופל צלול ואין לו הפרעה קוגניטיבית.

יש לשים לב להימנע מהגישה האוטומטית של התייחסות לאדם עם נכות כאל אדם הסובל מבעיה שכלית עם קושי בהבנה. יש לזכור שגישה זו לא רק פוגענית ואף עלולה ליצור אווירת מתיחות, אלא האבחנה יכולה להיפגע בשל הימנעות מתשאול מפורט כנדרש - כלומר המטפל לא עשה את המוטל עליו.

יש דוגמאות למכביר: חולי טרשת נפוצה, אנשים עם מחלות שריר ולעיתים אף אנשים שעברו אירוע מוחי. אומנם לאנשים אלו יש מגבלה גופנית שיכולה להיות משמעותית, אך יש להם תובנה, תפקוד שכלי תקין ויכולת תקשורת. לכן, על הגישה הרפואית הנכונה להיות זהה לזו של כל מטופל אחר, ללא שינוי בדרך ההתבטאות, ויש לנהל שיחה רגילה. כמו בכל מטופל, גם בטיפול בנכים יש לבקש רשות טרם הבדיקה, הטיפול, פרוצדורה או הפינוי ולהימנע מכל נימה מזלזלת או גישה כאל ילדים.

תשאול

כדי לעשות אבחון וטיפול אופטימלי יש לקבל ולדרוש את מרב הפרטים על הרקע לנכות, השלכותיה, טיפול תרופתי קבוע ואם נדרשת התייחסות מיוחדת. על ידי אנמנזה ספציפית ויסודית אפשר להגיע לזיהוי הבעיה הרפואית כדי לתת מענה מיטבי. במקרים שבהם קשה לאבחן את הבעיה הספציפית, יש להימנע ממתן אבחנה שגויה המיוחסת בטעות לתרופה או למנגנון שקשור לנכות.

הזהירות נדרשת גם בטרומה ובהערכה מוטורית ונירולוגית - חשוב להבין מה ביטוייה של הנכות הבסיסית ואת התפקוד הבסיסי להשוות למצב הנוכחי.

פינוי וניוד

חשוב מאוד להיות קשובים לבקשות ולהמלצות המטופל ומלוויו; יש לזכור שהם יוכלו להמליץ על פתרונות פינוי וניוד על סמך ניסיונם. יתרה מזאת, יש ליזום את השיחה, לשאול אותם לדעתם ולפעול לפי המלצתם אם הדבר אפשרי טכנית ותקין על פי הנהלים.

עם זאת - בכל מצב הכרוך בסכנת חיים, יש לפנות ולטפל במהירות האפשרית, גם אם זה יהיה כרוך באי־נוחות או בצורת פינוי השונה מדרך ההתניידות הרגילה של המטופל.

עיוורים, חירשים או אילמים

הטיפול באנשים עם מגבלה באחד מחמשת החושים: ראייה (עיוורים), שמיעה (חירשים) או באדם עם בעיית תקשורת מילולית (אילמים, חירשים) מציב בפני המטפל כמה אתגרים שחשוב להביא בחשבון מראש כדי להקל את התקשורת ולאפשר לתת את הטיפול המיטבי. עם זאת יש לזכור כי מדובר באדם עם מוגבלות ולא באדם מוגבל. לכן התקשורת המיטבית תביא בחשבון את האדם שיש לו מגבלה הספציפית.

(א) אנמנזה

בעיית התקשורת יכולה להיות הן בהבנת הצוות המטפל (בקרב אילמים) והן בהבנת המטופל (בקרב החירשים).

(ב) זרות

המגבלות החושיות עלולות ליצור אווירת חשדנות כלפי זרים בכלל וכלפי הצוות המטפל בפרט. החשדנות עלולה להתגבר בייחוד כשאנשים זרים (הצוות הרפואי) נכנסים למסגרת הביתית הפרטית. הדבר בולט במיוחד בקרב אנשים עיוורים.

(ג) גישה מומלצת

הצוות שמגיע לטפל באנשים עיוורים, חירשים או אילמים צריך להיות סבלני וקשוב יותר מתמיד, לבקש רשות לקראת כל מהלך ולהסביר את העומד לקרות לפני כל שלב בטיפול. מצופה מהמטפל לסייע במידת האפשר אף בנושאים הלא רפואיים דוגמת כיבוי המזגן והגז, נעילת הדלת, סחיבת ציוד אישי ואריזת בגדים. אשר לבעיית התקשורת, אפשר להיעזר בדוחות רפואיים מן העבר ולתקשר בסיוע כתיבה או מלווה היכול לתרגם לשפת הסימנים (לחירשים ואילמים).

מטופלים סיעודיים

ישנה הבחנה בין מטופל סיעודי למטופל סיעודי מורכב.

מטופל סיעודי

מטופל מוגדר כמטופל סיעודי כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים גם יחד:

- מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, גופני או מנטלי, והוא סובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי, לתקופה ארוכה.